

Stepped *care* GAD (NICE)

Cztery stopnie interwencji: od samopomocy do specjalistycznego oddziału. Tu rozpoznajesz, na którym jesteś — i co dalej.

CZAS: 20 min 1 sesja + decyzja o kolejnym kroku

ŹRÓDŁO: NICE CG113 (2011, akt. 2020); BAP (2014); WFSBP (Bandelow i wsp. 2023)

JAK UŻYWAĆ

Przeczytaj **4 stopnie stepped care** (sekcja 01). Określ swój **obecny stopień** (sekcja 02) — na podstawie nasilenia objawów, czasu trwania, funkcjonowania. Zaznacz **kryteria eskalacji** (sekcja 03) — kiedy iść wyżej. Cel: *nie* być za nisko (cierpieć bez pomocy) i *nie* być za wysoko (przeciążyć system / wydać niepotrzebne środki).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Model *stepped care* (NICE CG113) to standardowy schemat leczenia GAD w UK i większości krajów EU. Zasada: **najmniej intensywna interwencja, która zadziała**. Pacjenci często utykają na 1. stopniu, gdy potrzebują 3., albo idą prosto do 4., gdy 2. by wystarczył. Znajomość mapy pomaga: (a) *nie czuć się winnym* za korzystanie z wyższego stopnia, (b) *nie czekać latami* na poprawę, gdy obecny stopień nie działa, (c) *nie nadużywać* systemu (np. 4. stopień przy łagodnych objawach).

01 Cztery stopnie interwencji

1 IDENTYFIKACJA, OCENA, EDUKACJA, AKTYWNE MONITOROWANIE

objawy łagodne · GAD-7 5–9 · < 6 mies.

Działania: samopomoc (książki, aplikacje, materiały edukacyjne — np. ta seria handoutów), psychoedukacja od lekarza POZ, monitorowanie objawów co 2–4 tyg. (GAD-7), zmiany lifestyle (sen, ruch, kofeina, alkohol). *Nie* wymaga terapeuty. Większość przypadków łagodnego GAD ustępuje na tym stopniu.

2 INTERWENCJE NISKO-INTENSYWNE

objawy umiarkowane · GAD-7 10–14 · > 6 mies. lub brak poprawy ze stopnia 1

Działania: guided self-help (samopomoc prowadzona przez specjalistę 6–8 sesji), psychoedukacja grupowa (cCBT, 6–12 spotkań), aplikacje CBT z koordynacją terapeuty. *Mniej intensywnie* niż klasyczna terapia indywidualna, ale wprowadza strukturę i wsparcie. Skuteczność: 30–50 % remisji.

3 TERAPIA INDYWIDUALNA + / LUB FARMAKOTERAPIA

objawy umiarkowane-ciężkie · GAD-7 ≥15 · brak poprawy ze stopnia 2

Działania: CBT indywidualna 12–16 sesji (1 / tydz.), ACT, MCT, terapia rozwiązywania problemów. *Lub* farmakoterapia: SSRI (sertralina, escitalopram), SNRI (wenlafaksyna XR, duloksetyna), pregabalina. *Lub* kombinacja — najsilniejsza efektywność (Cuijpers i wsp. 2014: NNT=4). 40–60 % pełnej remisji.

4 SPECJALISTYCZNE LECZENIE

ciężki, przewlekły, oporny · GAD-7 >18 + komplikacje + brak poprawy z 3

Działania: ośrodki specjalistyczne (oddział dzienny, intensywna psychoterapia), zespół wielodyscyplinarny (psychiatra + psychoterapeuta + pielęgniarka), kombinacje farmakologiczne, leczenie współistniejących zaburzeń (depresja, uzależnienie, OCD). Stosowane przy braku odpowiedzi na 2 cykle leczenia 3. stopnia.

02 Mój obecny stopień

MÓJ WYNIK GAD-7 (OSTATNI)

— 0–4 *minimalne* / 5–9 *łagodne* / 10–14 *umiarkowane* / 15–21 *ciężkie*

JAK DŁUGO TRWAJĄ OBJAWY?

ILE POMOCY DO TEJ PORY?

— *samopomoc* / *aplikacja* / *terapia* / *leki*

CZY ONA DZIAŁA?

— *widoczna poprawa w ciągu 4–6 tyg.?*

MÓJ STOPIEŃ OBECNIE

— 1, 2, 3, czy 4?

03 Kryteria eskalacji — *kiedy iść stopień wyżej*

- ☐ Brak poprawy po **4–6 tyg.** obecnego leczenia
- ☐ Pogorszenie funkcjonowania w pracy / relacjach
- ☐ Pojawienie się **myśli samobójczych** (do stopnia 3–4 natychmiast)
- ☐ Sen < **5 h** przez 5+ nocy z rzędu
- ☐ Wzrost GAD-7 o **≥3 punkty** między ocenami
- ☐ Pojawienie się **depresji**, ataków paniki, dolegliwości somatycznych
- ☐ Sięganie po alkohol / leki nasenne codziennie
- ☐ Wycofywanie się z aktywności życiowych przez 2+ tyg.

Kiedy iść do specjalisty? Jeśli przez 4–6 tyg. obecnego stopnia nie ma widocznej poprawy — eskalacja. Nie czekaj na „dno” — wcześniejsza interwencja oznacza krótsze leczenie. **Eskalacja nie jest porażką** — to znak, że obecny stopień nie pasuje do nasilenia. Tak samo *de-eskalacja* (zejście w dół) po poprawie jest naturalna: po cyklu CBT (stopień 3) wielu pacjentów wraca do samopomocy + monitorowania (stopień 1) jako podtrzymanie.